EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92202
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-06 08:55:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ETELINDA ERICES RIVAS			RUN	: 14.240.019-7
F.Nac	: 10-01-1974	Edad	: 50 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: BULI ESTACION			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-01	Fecha Egreso	: 2024-09-06 08:55:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J45.9-ASMA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Asma severa e vias de compensacion
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J46.X-ASMA AGUDA SEVERA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE 50 AÑOS, ANTECEDENTE DE ASMA, REFIERE CRISIS FRECUENTES EN EL ULTIMO MES, REFIERE QUE TIENE BUENA ADHERENCIA A TRATAMIENTO, ANTECEDENTE DE INGRESOS A UCI POR PATOLOGIA RESPIRATORIA.
CONSULTA EN SERVICIO DE URGENCIA, POR PRESENTAR TOS, DISNEA Y SIBILANCIAS AUDIBLES SIN FONENDO, DIAFORETICA, TQUIPNEICA, CON USO DE MUSCULATURA ACCESORIA, DESATURANDO. REFIERE DE INICIO REPENTINO DE 3 HORAS DE EVOLUCION, SIN ANTECEDENTE DE ALERGIAS, ES EVALUADO POR MEDICO DE URGENCIA Y SE INDICA TRATAMIENTO BRONCODILATADOR + USO DE CORTICOIDE, CON MEJORIA PARCIAL, SE REALIZA EXAMENES DE LAB: PaFi. 259 pH: 7.36 PCO2 37 HCO3: 21 PO2 82.8 FIO2 32 LEUCO 20.60 SEGM 89% LINFO 8% PCR 13 LACTATO 2.0 CREAT 0.80. POR ANTECEDENTE DESCRITO ANTERIORMENTE DE HOSPITALIZACION EN LA UCI Y POR SINTOMAS QUE PARCIALMENTE CEDEN Y REQUERIMIENTO DE OXIGENO, SE DECIDE HOSPITALIZAR. SE TOMAN VIRUS INFLUENZA A,B, VIRUS SINCITIAL Y PANEL VIRAL.
SE CONTROLA CON GASES ARTERIALES PAFI= 445/ PaFi= 386 mmHg Adecuada PaFi

PACIENTE INGRESA A SERVICIO DE MEDICINA, CON LEVE MEJORIA, EN RELACION A SU LLEGADA EN LA URGENCIA, PRESENTA SIBILANCIAS AUDIBLES SIN FONENDO AL MINIMO ESFUERZO, SIN REQUERIMIENTO DE OXIGENO ACTUAL, DISNEICA, SIN SUSO DE MUSCULATURA ACCESORIA. SATURANDO 95% AMBIENTAL.

DURANTE SU ESTADIA HDN ESTABLE, AFEBRIL, SIN REQUEIRMIENTOS DE OXIGENO SUPLEMENTARIO, CON REHAILITACION KINESICA, ACTUALEMNTE HDN ESTABLE, CON EPISODIOS ESPORADICOS DE DISNEA, SE REINICIA TERAPIA CRONICA.
ACTUALMENTE CURSANDO SU DIA N° 6 HOSPITALIZADA, EN CONDICIONES DE CONTINUAR REHABILITACION KINESICA VIA HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflcito
2) Ventialtorio: Sin requeirmiento de O2 suplementario, se continuara hospitalizacion via HODOm para rehabilitacion kinesica

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo asistido
2. Régimen liviano hiposodico para diabeticos
3. Salbutamol 4 puff c/6hrs por AC
4. Bromuro de ipratropio 4 puff c/8hrs por AC
5. Prednisona 20 mg al dia VO por 7 dias
6. Losartan 50 mg al dia VO por 7 dias
7. Omeprazol 20 mg al dia VO por 7 dias
8. KNT respiratoria una vez al dia
9. Relvar 1 puff al dia
10. Tiotropio 2 puff al dia
11. CSV c/8hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO